2023학년도 소아청소년과 학년말고사 (231106)

* 60분 시험(CBT)

총 **50문항** 중 **50문항** 복기.
총평: 예고하신 대로 post test 문제에서 일부 출제하셨습니다. 신생아 파트, 이경석P(추정) 파트에서도 탈야마해서 체감 상 새로운 문제들이 많다고 느꼈습니다.

1. (Y) 미숙아는 Gestational age 기준으로 몇주 미만인가?
① 36주
② 37주
③ 38주
④ 39주
⑤ 40주

2. 39주, 2,400g, 키 49cm, 두위 34cm의 환아가 비대칭적으로 성장하였다. 원인으로 흔치 않은 것은?
① 선천성 풍진
② 산모의 만성적인 고혈압
③ 산모의 만성적인 합병증을 동반한 당뇨
④ 산모의 임신 말기 영양결핍
⑤ 임신 중 전자간증 Calcium

3. (Y) 심박수 60, 호흡 느리고 불규칙, 사지는 약간 굴곡되어 있었고, 손발은 청색, 몸통은 분홍색이었다. 카테터 자극에 반응 없었다. 5분 APGAR score는?
① 1점 ② 2점 ③ 3점
④ 4점 ⑤ 5점

4. 모유 영양에 관하여 적절한 것은?
① 조기 모유 황달시 모유수유를 중단한다.
② 초유에는 평소 모유보다 더 많은 지방이 함유되어있다.
③ 모유의 지방 함량은 우유보다 많다.
④ 모유의 단백질은 주로 casein이다.
⑤ 완전 모유 수유시 4-5개월부터 철분을 보충해줘야 한다.

5. 재태연령 26주, 700g으로 태어나 분유 먹고 있는 신생아. 생후 15일째에 혈변이 발생했다. 아기는 늘어져 있었고, 신체 진찰 했을 때 복부 팽만, 청진 시 장음 감소되어있었다. X-ray 소견 제시됨.(장에 gas 가득 차 있는 사진) 치료는?

혈액 검사 결과: IgE 50, eosinophil 1000

① 유단백가수분해분유
② 항생제
③ 비스테로이드소염제
④ 수술
⑤ 글루코코르티코이드

6. 재태연령 28주, 1.4kg로 태어난 신생아로, 청색증과 호흡곤란, 흉벽 당김이 있다. 영상 소견의 경우 다음과 같다.



다음 질환의 병태생리 중 틀린 것은?
① 폐 표면장력이 감소되어 있다.
② 폐 순응도(Compliance)가 감소되어 있다.
③ 일정 압력(Pressure)당 폐공기량(Volume)이 감소되어 있다.
④ 폐 표면활성제의 부족으로 무기폐가 생긴다.
⑤ 분만에 비해 C/sec하는 경우 더 많이 발생한다.

7. (Y) 재태연령 26주, 1.5kg로 태어난 신생아로, 흉벽당김, 빈호흡, 청색증 있었다. 영상 소견은 다음과 같을 때, 치료는?



① surfactant PO
② surfactant IV
③ surfactant 기관 내
④ dexamethasone PO
⑤ dexamethasone IV

8. 태어난 지 1시간 된 신생아, asphyxia를 주소로 내원한 신생아. 신경학적 검사 결과 늘어져있었고, 저긴장증 보였다. 2시간 지난 뒤 경련 보였고, 대사성 산증, 저혈당증 보였다. 뇌 손상 막기 위한 치료는?
① 저체온 요법
② 항바이러스제
③ 혈장 교환술
④ 줄기 세포 이식
⑤ 비스테로이드소염제

9. 신생아 황달에서 원인을 찾을 필요가 없는 경우는?
① 생후 24-36시간 이내에 발생한 경우
② 황달이 10-14일 이상 지속되는 경우
③ 빌리루빈의 증가 속도가 5mg/dL/day 이상인 경우
④ 만삭아에서 총 빌리루빈이 12mg/dL 이상인 경우
⑤ 정답 없음

10. (post-test) 다음 방사선 사진에서 보이지 않는 것은?
① endotracheal tube (기도 내 삽관)
② central venous line (중심정맥관)
③ arterial line (동맥관)
④ gastric tube
⑤ foley catheter

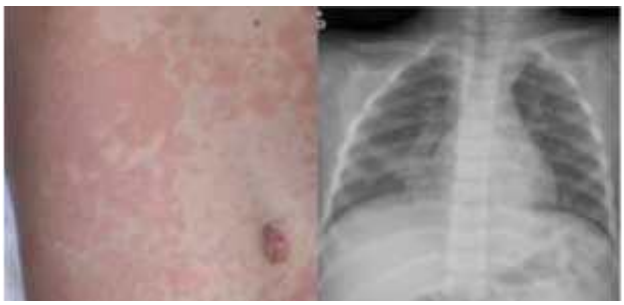
11. 재태연령 41주, 출생 체중 4300g, 난산, 질분만한 신생아가 출생 직후 왼 팔이 움직이지 않았다. 왼쪽 빗장뼈가 융기된 부분이 있었고, 만졌을 때 마찰음이 있었다. 머리를 30도 들어서 갑자기 내려놓았을 때 오른쪽 팔은 쭉 뻗은 후 구부렸으나, 왼쪽 팔은 움직이지 않았다. 치료는?
① 어깨와 팔 고정
② 항생제
③ 비스테로이드소염제
④ 뜨거운 찜질
⑤ 수술

12. 조산아의 보온 능력에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 미숙아의 경우 피하 지방이 두꺼워서 체온 유지가 잘 된다.
② 신생아는 성인에 비해 체중 대비 체표면적이 약 3배이다.
③ 신생아의 열 손실은 대류, 전도, 복사, 수분증발로 일어난다.
④ 신생아에서 출생 직후 추위 노출시 대사성 산증, 저혈당증, 저산소증을 일으킨다.
⑤ 저혈당증, 저산소증 신생아에서 추위에 노출되면 산소 소비가 증가되지 않아서 중심체온이 떨어진다.

13. 미숙아 영양 공급에 대해서 틀린 것 고르시오
① 초극소, 극소 저체중 아기에게 조기 장관영양은 권장되지 않는다.
② 저체중 출상아에게 모유, 특히 초유는 장관 영양에 반드시 필요하다.
③ 조산아는 이환율 및 사망률이 증가하며 다양한 이환율은 임신 주수가 낮을수록 출생 체중이 낮을수록 증가한다.
④ 조산아는 감염 시 임상증상이 뚜렷하지 않아 신생아간 전파를 막기 힘들다.
⑤ 초극소 저체중 아기 출생 후 포도당 및 아미노산 투여가 필요하다.

14. 10세 남아 무릎 아래 통증 및 종창으로 내원하였다. 과거 3세에 안과에서 오른쪽 안구 적출 후 방사선 치료 병력 있다. 환자의 영상 검사 사진은 다음과 같다. 환자의 질병 발병과 관련된 유전자는?
① Rb
② p53
③ PMAL-RARA
④ AML

15. (Y) 초등학교에 다니는 9 세 여아가 8 일간 지속된 발열과 발작적인 마른 기침으로 왔다. 두통과 복통도 같이 호소하였다. 체온은 38.4'C, 체간에 사진과 같은 홍반구진상발진(maculopapular eruption)이 있고 양측 폐에서 나음이 청진되었다. 냉응집소 1:128. 해당 질환에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 복통, 심막염, 뇌수막염, 근육통 등 폐외 증상이 동반될 수 있다.
② 페니실린계로 치료한다.
③ 냉응집소 증가는 이 질환에서만 특징적이다.
④ 일반적으로 매년 유행하고, 여름에 유행한다.
⑤ 면역력이 약한 영유아가 잘 걸린다.

16. (Y) 발열, 기침, 콧물로 내원한 환아이다. 결막충혈 있었음. 사진과 같은 증상이 있었다. 합병증 중 가장 많은 사망원인은?



① 폐렴
② 중이염
③ 뇌염
④ 관절염
⑤ 아급성 경화 전뇌염

17. (Y) 5 세 남아가 발열로 내원, 경부강직 있었고 CSF는 다음과 같다. 진단은?

WBC 150(Lympho 100%), 압력 12cmH_2O, RBC 8 단백질 25

① 바이러스성 뇌수막염
② 결핵성 뇌수막염
③ 세균성 뇌수막염

18. 5세 남아가 안면 창백을 주소로 내원하였다. 신체진찰상 환자의오른쪽 손가락이 2 개로 기형이 동반되었다. Hb 4.5, WBC 1,500(ANC 320), PLT 39,000. Hb는 상승해있었다. BM cellularity는 10%였다. 환자의 초기 치료로 적절한 것은?
① prednisone
② Hematopoietic growth factor
③ Anti-Thymocyte globulin
④ Hematopoietic stem cell transplantation
⑤ Transfusion only

19. 위식도역류 검사에 관하여 옳은 것을 고르시오.
① 위조영술의 진단적 정확도는 90%이상이다.
② 산도 측정 검사는 기도 역류를 확인할 수 있다.
③ 위내시경은 역류의 정도를 알 수 있다
④ manometry는 역류의 volume을 측정할 수 있다.
⑤ 식도 스캔 검사는 상부 식도까지 역류했는지 알 수 있다.

20. 소아 만성 기능성 복통 증후군에 대해 옳은 것은?
① 주로 식사 전에 아프다
② 혈변과 토혈을 동반한다.
③ 일상생활(학교수업 등)을 할수 없을 정도로 아프진 않다.
④ 주로 6세 이전에 흔하다.
⑤ 주로 중심성 통증을 호소한다.

21. 10세 남아가 급성 췌장염 소견에 대한 치료로 일주일 넘게 금식하다가 배가 너무 고파하자 보호자가 몰래 간식을 사와 먹였다. 2시간 후 환아의 양손에 tremor가 나타났고 아이가 심한 복통, 구토를 호소했다. 다음 중 추적해야 하는 수치는?
① Calcium
② Phosphorus
③ Ammonia
④ Chloride
⑤ Glucose

22. 담즙 정체증으로 생후 1개월때부터 현재까지 병원에 다니며 진료받는 5개월 남아가 있다. 병명은 신생아 간염이라고 한다. 아기의 체중은 7kg이며 간간이 보채고 잘 먹지 않는다고 한다. 생화학 검사 소견은 ALT는 158U/L, 총 빌리루빈은 9.9mg/dL이며, 직접형 빌리루빈은 4.5mg/dL이다. 이 수치는 1개월 전보다 약간 상승한 것이므로 의사는 이 환아에게 아무래도 몇 가지 약제를 처방하는 것이 좋다고 판단하였다. 이 환아에게 처방할 약제들로서 선택제재와 요량이 맞는 것은 다음 중 어느 것인가?
① 구리 제재를 매일 먹인다.
② Vitamin K 5mg를 매일 투여한다.
③ 스테로이드제를 한 달간 투여한다.
④ Vitamin D3를 400IU 매일 먹인다.
⑤ Vitamin E를 하루 400IU 먹인다.

23. (Y) 생후 20개월 된 남아가 발열을 동반한 호흡곤란과 쌕쌕거림으로 왔다. 생후 6개월, 13개월 때도 유사한 증상 (호흡곤란, 천명발작)으로 응급실에 갔었던 적이 있으며 가족력에서 어머니가 알레르기비염이 있었다. 체온은 39.5°C이며 혈액검사 결과는 다음과 같았다. 다음 중 급성 세기관지염과 구별하여 영아천식으로 진단할 수 있는 임상 소견 중 맞는 것은?

WBC 12,000/mm^3 , 호산구치 700/mm^3, 혈청 CRP 0.5 mg/dl(정상치: 0.1~0.8 mg/dl), 혈청 ESR 11mm/hr (정상치 0~10mm/hr), IgE 15 IU/mL (소아 1~5 세 정상치 ~60 IU/mL)

① 반복적인 천명 발작
② 고열
③ 쌕쌕거림
④ 혈청 IgE 15 IU/ml
⑤ 총 호산구 700/mm^3

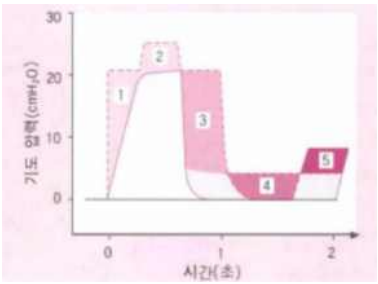
24. (Y) 영유아 호흡기 특징으로 옳은 것은?
① 2세에 성인 호흡으로 전환된다.
② 상기도 안지름은 크고 후두개는 작다.
③ 성인에 비해 점액샘 밀도가 낮아 분비가 적다.
④ 연골이 잘 발달되어있어 협착이 잘 안된다.
⑤ 늑간근의 제 2 연축섬유 많아 지속적 호흡에 유리하다.

25. (Y) 13 세 여아가 매년 환절기때마다 생기는 코가려움, 코막힘, 재채기, 콧물, 훌쩍거림, 눈가려움 증상을 주소로 왔다. 어려서 아토피 피부염을 앓았으며 어머니가 어렸을 때 천식을 앓았었다고 한다. 혈액 검사는 다음과 같았다. 내원시 콧물 재채기로 학교생활에 불편함이 있어 2 주간 치료 후 다시 병원에 오기로 하고 약을 처방 하였다. 2 주간 처방할 수 있는 치료제로 옳은 것은?

호산구 1000/mm3, 혈청 IgE 570 IU/mL

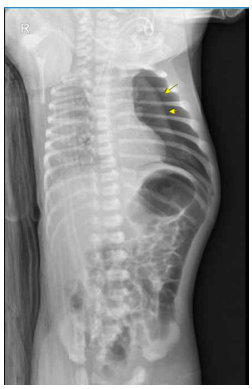
① 스테로이드 국소 분무제(nasal spray)
② 비충혈 제거제 (Decongestant)
③ 항생제
④ 전신 스테로이드제
⑤ 흡입 스테로이드제

26. (Y) 평균 기도압력을 높이는 방법으로 4 에 해당하는 방법은?



① 흡기 유속 증가
② 최대 흡기 압력 증가
③ 호흡 횟수 변경 없이 흡기 시간을 연장시킨다.
④ 호기말 양압을 증가시킨다.
⑤ 호기 시간을 줄여서 인공환기의 환기수를 증가시킨다.

27. (post-test) 다음이 가리키는 것을 쓰시오.



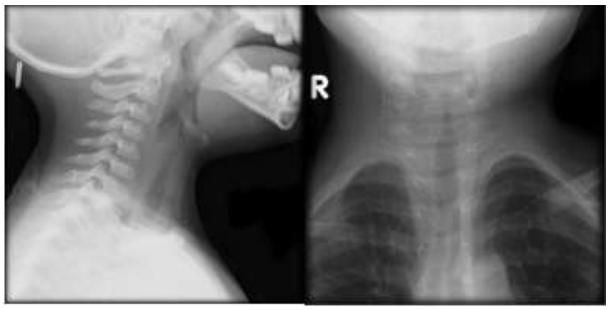
① 공기가슴증(Pneumothorax)
② 호흡곤란증후군(Respiratory distress syndrome)
③ 폐렴(Pneumonia)

28. (Y) 8 개월 남아가 3 일전부터 발열, 콧물, 기침 있었고, 1 일전부터 전부터 기침이 심해 지면서 먹지 못하고 쳐졌다고 한다. 양쪽 가슴에 갈비사이 뒤당김이 있다. 가슴청진에서 날숨에서 쌕쌕거렸고, 심잡음은 없다. 치료는?

WBC 14900, 호산구 700/mm^3

① 수액 보충
② 에피네프린 흡입
③ 항생제 치료
④ 스테로이드 정주
⑤ 진정제 투여

29. (Y) 2 세 여아 발열과 컹컹 거림을 주소로 내원. 산소포화도 95% 호흡수 분당 40 회. 흉부함몰 있었고 예방접종은 다 맞음. 다음은 가슴과 목 옆면 x 선 사진이다. 치료는?



① 에피네프린 흡인
② 기관 삽관
③ 아목사실린
④ 수액 보충

30. (Y) 3 세 소아가 10 일간 상기도 감염 증상을 보이다가 어제부터 발작적인 기침이 발생하였다. 기침의 양상은 발작적인 짧은 호기성 기침이 연발되다가 끝에 길게 숨을 들이쉬며 ”흡”하는 소리를 내는 것이었다. 혈액검사 결과가 다음과 같을 때, 치료는?

WBC 13,200 (PMN 16%, Lympho 84%)

① 에리스로마이신
② 반코마이신
③ 아미노글리코사이드
④ 페니실린
⑤ 세팔로스포린

31. 특별한 기저질환 없고 건강한 주산기를 보냈으나 체중(3 percentile 이어서 신생화중환자실에서 TORCH 검사를 받은 생후 5개월 환아. (검사1) 환아는 3개월 째에 RSV bronchiolitis 병원에서 치료받고 퇴원 한 후 지속적으로 간수치가 상승되어 있어서 의뢰됨. (검사2) 외래에서 진행한 신체검사 상 이상소견 없었고 혼합분유 먹으며 체중 잘 늘고 있음. 이 환자에 가장 적절한 진단은 무엇인가?

검사1.	Toxoplasma IgG/IgM: negative
	Rubella IgG/IgM: negative
	HSV IgG/IgM: negative
	CMV IgG: positive
	urine CMV RQ-PCR: negative
	urine CMV culture: no growth
검사2.	HbsAg(-) HbsAb(+) HAV IgG/IgM(-/-)
	AST/ALT 245/324 GGT 164
	Total bilirubin 1.0 direct bilirubin 0.2
	PT/aPTT 0.9/40sec
	serum CMV RQ-PCR 1,250,000
	serum RQ-PCR 6,500,000

① Neonatal hepatitis
② RSV hepatitis
③ Perinatal CMV hepatitis
④ Congenital CMV infection
⑤ Transient hepatitis

32. (post-test) 다음 사진 중 왼쪽은 심기형을 치료하는 시술 과정에 대한 사진이고, 오른쪽은 시술 후의 흉부 방사선 사진이다. 해당하는 심기형은?

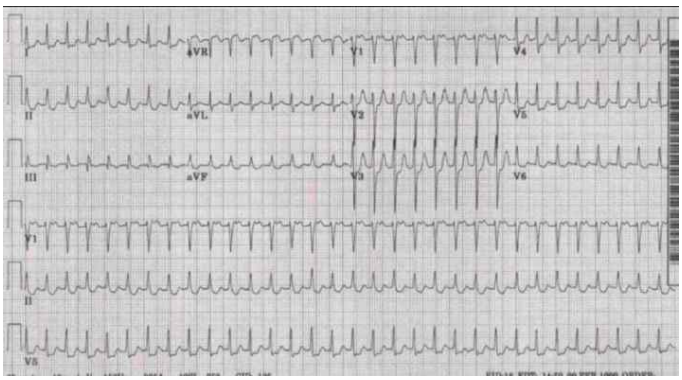



① Atrial septal defect
② Ventricular septal defect
③ Pulmonary valvar stenosis
④ Coronary aneurysm of Kawasaki disease
⑤ 전극도자술

33. 다음 중 팔로사 징후에서 나타나지 않는 것은?
① Left ventricular outflow tract obstruction
② Ventricular septal defect
③ Overridng aorta
④ Pulmonary stenosis
⑤ Right ventricular hypertrophy

34. (post-test) Dental care 받는 환자 중 감염성 심내막염 방지 위해 예방적 항생제 써야 하는 환자가 아닌 것은?
① VSD closure devices when complete closure is achieved
② Unrepaired cyanotic congenital CHD, including palliative shunt and conduits
③ Previous, relapse, or recurrent IE
④ Cardiac transplant recipients who develop cardiac valvulopathy
⑤ Presence of cardiac prosthetic valve

35. (post-test) 기저질환 없는 11세 남아가 평소 두근거리는 느낌이 있다가 내원 당일 심하게 두근거리는 양상으로 본원 ER 내원하였다. 당시 측정한 HR 213회/분, BP 85/52mmHg, SpO2 98%, RR 20회/분이었고, EKG는 다음과 같았다. 진단과 적절한 처치는?



① Sinus tachycardia - 안심시키고 경과 관찰
② Ventricular tachycardia - Beta blocker
③ Atrial fibrillation - Defibrillation
④ PSVT - adenosine
⑤ Thyrotoxicosis - iodine

36. 돌 된 아이. 3개월 전 가와사키 병으로 IVIG, aspirin 처방받았다. 미뤄야 할 예방접종으로 가장 옳은 것은?
① 불활성화 폴리오 백신
② DTaP
③ Haemophilus influenzae b (Hib)
④ MMR
⑤ 인플루엔자

37. 8세 남아가 2시간 전부터 갑자기 의식을 잃어서 병원에 왔다. 한 달 전부터 물을 많이 마시고, 소변을 자주 봤다고 한다. 한 달 간 체중이 4 kg 빠졌고, 2일 전부터는 배가 아프고 토했다고 한다. 혈압 100/70 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 40회/분, 체온 37.0℃이다. 입술과 혀는 말라 있다. 검사 결과는 다음과 같다. 가장 먼저 할 치료는?

혈액: Na+/K+ 130/3.8 meq/L, 혈당 350 mg/dL 동맥혈가스분석(대기호흡): pH 7.05, PaCO2 15 mmHg, PaO2 112 mmHg, HCO3- 8 meq/L 소변: 케톤 (4+), 포도당 (3+)

① 생리식염수
② 중탄산염
③ 항생제
④ 만니톨
⑤ 인슐린

38. 10세 남아 2시간 전 의식이 소실된 상태로 발견되어 응급실에 실려 왔다. 2주 전부터 소변을 자주 봤고 4일 전부터 배가 아프고 토하였다고 한다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.3℃이다. 혀와 구강점막이 말라 있다. 복부 압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

혈액: 백혈구 10,000/mm^3, 혈색소 12.0 g/dL, 혈소판 260,000/mm^3, 혈액요소질소/크레아티닌 25/1.5 mg/dL, 포도당 740 mg/dL, Na+/K+/Cl- 122/3.4/89 meq/L 동맥혈가스(대기호흡): pH 7.1, HCO3- 5 meq/L

① 당뇨병성 케톤산증
② Glycosuria
③ RTA
④ Hyperosmolar nonketoacidic state

39. 7세 여아 유방 발달로 내원. 뼈나이 7세. 유방 태너 2단계, 음모 태너 1단계. 검사는?
① 성선자극호르몬과 성호르몬
② 성선자극호르몬방출호르몬 자극검사
③ 골반초음파
④ 염색체이상
⑤ 검사없이 추척관찰

40. 터너증후군 환아 사진 및 염색체 검사 결과 (XO) 제시. 옳은 것은?
① 골연령과 역연령이 같다.
② 성장호르몬 자극검사를 하면 peak GH가 낮다.
③ 사춘기 급성장이 정상적으로 나타난다.
④ 성장속도가 6cm/1년이다.
⑤ 출생 시 체중이 정상보다 크다.

41. 생후 8일된 남자 아이가 신생아 선별 검사에서 갑상선 자극 호르몬 수치가 높아서 시행한 갑상선 기능 검사 결과가 다음과 같았다. 원인으로 가장 흔한 것은?

트라이아이오도티로닌: 100 ng/gL (75-260) 유리 티록신: 0.3 ng/dL (0.9-2.6) 갑상선 자극호르몬: 58 uU/mL (0.5-6.5)

① 딴곳 갑상샘
② 갑상샘 무형성
③ 효소 결핍
④ 만성 림프구성 갑상선염

42. 10세 남아가 키가 작아서 병원에 왔다. 키 2백분위수, 체중 25백분위수 였다. 최근 1년 동안 키가 3.5cm 컸다. 아버지는 175cm, 어머니는 160cm 였다. 골연령은 8세였다. 아버지는 중학교 때 키가 컸고 어머니 초경 연령은 13세였다. 진단은?
① 성장호르몬 결핍증
② 쿠싱증후군
③ 체질성 성장지연
④ 가족성 저신장
⑤ 터너증후군

43. 6세 남아가 밤에 자는 도중에 소리를 지르고 몸부림을 치며 일어난다. 일어난 후에는 호흡 가쁘고, 동공이 확산되며, 땀에 젖어 있었고, 밤의 상황을 기억하지 못했다. 진단은?
① 야경증
② 악몽
③ REM 수면이상
④ 경련

44. 5세 남아가 점점 걷기가 서툴러져서 병원에 왔다. 임신 나이 40주, 출생체중 3,200g 및 질식분만으로 태어났다. 15개월에 혼자 걷기 시작하였으나 4개월 전부터 점차 다리를 넓게 벌리고 허리를 흔들어 걷고, 자주 넘어졌다. 혼자 일어서기를 힘들어 하며, 배를 내밀고 서 있었다. 장딴지 근육이 딱딱하고 비대하져 있었다. 진단은?
① Duchenne muscular dystrophy
② 중증 근무력증
③ 뇌성 마비
④ Digeroge syndrome

45. 5세 여아가 발달이 느린 것과 피부질환, 뇌전증으로 내원하였다. 전신에 1.5-3cm의 피부반점들이 있었고 어머니에게도 똑같은 병변이 관찰되었다. 아래는 피부반점, X-ray, MRI 사진이다. 다음과 같은 소견을 보이는 질환에서 나타나는 유전자 이상으로 옳은 것은?



① NF1 유전자 돌연변이
② NF2 유전자 돌연변이
③ TSC1 유전자 돌연변이
④ TSC2 유전자 돌연변이
⑤ APLD1 유전자 돌연변이

46. 7세 아이 몸에 밀크커피색 반점이 있다. 겨드랑이에도 반점이 있고 어머니도 동일한 증상과 함께 뇌종양이 있다. 진단은?



① Neurofibromatosis
② Tuberous sclerosis
③ Sturge Weber syndrome
④ Multiple sclerosis
⑤ Incontinentia pigmenti

47. 아래 설명에 해당하는 질환은?

> X 연관이 흔하고 상염색체 열성, 혹은 산발로 일어나는 경우도 있다. T cell과 관련해서는 정상이다. 산모에게서 받은 항체가 사라지는 6-9개월에 세균 감염이 잦게 나타난다. IgA, IgM, IgG이 95% 이하로 떨어지면 총감마글로불린이 100mg/dL 이하로 나타난다. 치료로는 부족한 감마글로불린을 보충한다.

① Digeorge syndrome
② 범저감마글로불린 혈증
③ Chediak-Higashi syndrome
④ Wiskott-Aldrish syndrome
⑤ Alport syndrome

48. 아나필락시스에 관하여 옳은 것을 고르시오.
① 응급조치로 H2 길항제를 정맥주사한다.
② 응급조치로 에피네프린을 정맥주사한다.
③ 소아청소년과 병원 외에 대표적 원인은 식품이다.
④ 피부, 점막 증상이 있어야 진단할 수 있다.
⑤ 혈압 저하가 있어야 진단할 수 있다.

49. 10세 소아가 뱀에 물렸다. 올바른 것을 고르시오.
① 파상풍 예방접종을 맞아야 한다.
② NSAID를 투여한다.
③ 얼음 찜질을 하여야 한다.
④ 독 있는 뱀과 없는 뱀은 이빨자국으로 구분할 수 없다.
⑤ 우리나라는 항응고와 항혈전보다 신경독성이 있는 독이 많다.

50. 소아 심폐소생술에 관하여 옳은 것은?
① 빈맥시 인공심장박동기 시술을 한다.
① 서맥시 리도카인 준다
③ 분당 120회 흉부압박을 한다
④ 아이가 몸이 크더라도 나이에 맞춰 시행한다.
⑤ 가족 참관을 자율적으로 결정할 수 있다.